REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

EPISTAXE

Anatomia, anterior × posterior, causas, tratamento escalonado e situações especiais em uma página

MAIS COBRADO · 1º Anterior × posterior · 2º Tratamento escalonado · 3º Tamponamento posterior interna · 4º Anticoagulado: medidas locais primeiro

1 ANATOMIA E CLASSIFICAÇÃO

estável? anterior ou posterior? causa a corrigir?

	Anterior (~90%)	Posterior (5–10%)
Origem	**Plexo de Kiesselbach** (área de Little), septo anterior	**Artéria esfenopalatina** (a. maxilar, carótida externa)
Perfil	Criança, trauma digital; benigna, fácil de controlar	**> 40 anos**, HAS, aterosclerose, AAS/anticoagulante; grave
Exame	Ponto ou crosta visível na rinoscopia anterior	**Sangue na orofaringe**, sangra mesmo com compressão

Irrigação: carótida interna → oftálmica → **etmoidais** anterior e posterior · carótida externa → maxilar → **esfenopalatina** e palatina maior; facial → labial superior. 60% terão um episódio na vida; picos < 10 e 70–79 anos; mais no **inverno** (ar seco).

2 CAUSAS E AVALIAÇÃO

Locais: trauma (digital na criança, fraturas, sondas), **corpo estranho** (unilateral, rinorreia fétida), rinite, desvio de septo, cirurgia, **angiofibroma juvenil** (adolescente masculino, unilateral profusa), O_2 prolongado. **Sistêmicas:** HAS, coagulopatias (von Willebrand), anticoagulantes/antiagregantes, **Rendu-Osler-Weber**, cocaína, álcool, neoplasias hematológicas.

Grave (volumosa, bilateral, pela boca, hipovolemia): **ABCDE** e comprimir enquanto colhe a história. Choque: taquicardia → taquipneia → hipotensão (tardia). Rinoscopia anterior após aspirar coágulos + olhar a orofaringe. Exames só nos graves ou recorrentes: hemograma, coagulograma (INR), **nasofibroscopia** (acha o ponto em 87–93%). Diferenciais: hemoptise, hematêmese (sangue deglutido).

3 TRATAMENTO ESCALONADO

do menos ao mais invasivo

Passo	Como
1. Compressão	Asas nasais contra o septo (parte **mole**), **5–10 min** (até 15), sentado e inclinado para a frente; compressa fria
2. Vasoconstritor	**Oximetazolina** (65–75%) ou adrenalina 1:1000 + lidocaína 2%; cautela em hipertenso e cardiopata
3. Cauterização	Nitrato de prata ou ATA no ponto; **nunca bilateral** no septo (perfuração)
4. Tampão anterior	Gaze vaselinada ou esponja, 24–48 h (diretriz: 48–72 h, máx. 5 dias); **reabsorvível** em coagulopata e anticoagulado
5. Tampão posterior	**Foley**, gaze em peteca ou duplo balão (~70%); **internação e monitorização** (hipóxia, reflexo vagal)
6. Cirurgia	Cauterização endoscópica · **ligadura da esfenopalatina (TESPAL, até 98%)** · embolização (~87%; necrose, cegueira, AVC)

4 SITUAÇÕES ESPECIAIS

Anticoagulado ou antiagregado: sem risco de vida, começa pelas **medidas locais**. Varfarina: complexo protrombínico + vit. K (nunca só vit. K) · heparina: protamina · dabigatrana: idarucizumabe · antiplaquetário: plaquetas (pouco eficaz com droga ativa). AAS: efeito dura **7–10 dias**. Grave = posterior, instável ou queda de Hb ≥ 2 g/dL.

Rendu-Osler-Weber (autossômica dominante): critérios de **Curaçao** (epistaxe recorrente, telangiectasias, MAV visceral, parente de 1º grau): 3 = definitivo · 2 = possível. Tampão reabsorvível. **HAS**: não baixar a PA de rotina (isquemia); monitorizar. Complicações: anemia, choque, sinusite, perfuração septal, choque tóxico.

NÃO CONFUNDA NA PROVA

Os distratores que mais derrubam

1. **Comprimir o osso nasal** não funciona: aperte a parte mole.
2. **Cabeça para trás** está errado: incline para a frente.
3. **Sangue na orofaringe** = posterior.
4. **Após os 40 anos** a posterior fica mais comum.
5. **Cauterizar os dois lados** do septo perfura.
6. **Artérias etmoidais** não se embolizam (cegueira): ligam-se.
7. **Tampão posterior** sempre interna.
8. **Antibiótico com tampão** é controverso na diretriz.
9. **Suspender AAS** não reverte o efeito na hora.
10. **Adolescente com epistaxe unilateral profusa**: angiofibroma juvenil.
11. **Epistaxe bilateral recorrente** + família: pense em Rendu-Osler.

NÚMEROS QUE CAEM

Anterior **90%** · posterior **5–10%** · corte de idade **40 anos**
Compressão **5–10 min** · tampão anterior **24–48 h**
TESPAL **98%** · embolização **87%** · nasofibroscopia **87–93%**